

รายงาน

ข้อมูลแบบแผนสุขภาพ (Functional Health Pattern)

จัดทำโดย

นางสาวสุริฉาย	หมื่นจันทร์	6901031401095
นางสาวเอเชีย	จันทองสูง	6901031401107
นางสาวนาซูฮา	มีระยะ	6901031401115
นางสาวนาดา	มะดีเยาะ	6901031401116
นางสาวโสรยา	เจะเตะ	6901031401127

เสนอโดย

อาจารย์ไบตุลมาลย์ อาแด

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาระความรู้ขั้นพื้นฐาน รายวิชาเลือกบังคับ
วิชาระบบสุขภาพและกลไก (4961124)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำนำ

รายงานเรื่อง ข้อมูลแบบแผนสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการดำเนินชีวิตของนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ การจัดการความเครียด การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

การศึกษาแบบแผนสุขภาพของนักศึกษามีความสำคัญ เนื่องจากช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค และสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพของนักศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

หัวข้อ **หน้า**

คำนำ ..... ก

สารบัญ ..... ข

1. **การรับรู้และการดูแลสุขภาพ** 1

2. **ภาวะโภชนาการและเมตาบอลิซึม** 2

3. การขับถ่าย 4

4. กิจกรรมและการออกกำลังกาย 4

5. การนอนหลับพักผ่อน 5

6. การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์ 6

7. เพศสัมพันธ์และการเจริญพันธุ์ 6

8. บทบาทและสัมพันธภาพ 8

9. สติปัญญา การรับรู้และประสาทสัมผัส 9

10. ความเครียดและความทนต่อความเครียด 11

11. ความเชื่อและค่านิยม 11

ผลการประเมินภาวะสุขภาพและแบบแผนสุขภาพของผู้ป่วย 13

สรุปผลการประเมินโดยรวม 13

ข้อมูลแบบแผนสุขภาพ (Functional Health Pattern)

ข้อมูล	ชาย		หญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การรับรู้และการดูแลสุขภาพ				
1.1. ซักถาม				
- ผู้ป่วย	5	33.3%	10	66.7%
- บิดา/มารดา	-	-	-	-
- สามี/ภรรยา	-	-	-	-
- ญาติ	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
1.2. สุขภาพก่อนการเจ็บป่วย				
- ดี	5	33.3%	10	66.7%
- ไม่ดี	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
1.3. การดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย				
- ไปรพ. / สถานีอนามัย	-	-	4	26.7%
- ซื้อยารับประทานเอง	5	33.3%	6	40%
- อื่น	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
1.4. ความคาดหวังเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในครั้งนี้				
- คิดว่าหาย	4	26.7%	9	60%
- ไม่แน่ใจ	1	6.7%	1	6.7%
- ไม่หาย	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
1.5. การเสพสิ่งเสพติด				
- ไม่เคย	4	26.7%	10	66.7%
- เคย	-	-	-	-
- ดื่มสุรา (เป็นเวลา 1 ปี)	1	6.7%	-	-

- ปัจจุบันเลิกเสพ	-	-	-	-
- ปัจจุบันยังไม่เลิกเสพ	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากการศึกษาข้อมูลแบบแผนสุขภาพด้านการรับรู้และการดูแลสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน (ร้อยละ 100) เป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ส่วนใหญ่เลือกซื้อยารับประทานเอง โดยเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 6 คน (ร้อยละ 40) ขณะที่เพศหญิง 4 คน (ร้อยละ 26.7) เลือกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยสำหรับความคาดหวังเมื่อเข้ารับการรักษาในครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วย โดยเป็นเพศชาย 4 คน (ร้อยละ 26.7) และเพศหญิง 9 คน (ร้อยละ 60) ส่วนผู้ที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลการรักษามีเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน นอกจากนี้ ด้านการเสพสิ่งเสพติด พบว่าเพศชาย 4 คน (ร้อยละ 26.7) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) ไม่เคยเสพสิ่งเสพติด ขณะที่เพศชาย 1 คน (ร้อยละ 6.7) ระบุว่าดื่มสุรา เป็นเวลา 1 ปี

2. ภาวะโภชนาการและเมตาบอลิซึม				
2.1. น้ำหนัก				
41 - 50	-	-	6	40%
51 - 60	1	6.7%	3	20%
61 - 70	2	13.3%	1	6.7%
71 - 80	-	-	-	-
81 - 90	1	6.7%	-	-
91 - 100	-	-	-	-
101 - 110	1	6.7%	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
2.2. ส่วนสูง				
141 - 150	-	-	1	6.7%
151 - 160	-	-	6	40%
161 - 170	2	13.3%	3	20%
171 - 180	2	13.3%	-	-
181 - 190	-	-	-	-
191 - 200	1	6.7%	-	-

รวม	5	33.3%	10	66.7%
2.3. ค่า BMI				
17.4 – 20.0	-	-	7	46.7%
20.1 – 22.7	3	20%	1	6.7%
22.8 – 25.4	-	-	1	6.7%
25.5 – 28.1	-	-	1	6.7%
28.2 – 30.8	2	13.3%	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
2.4. อาหารที่รับประทาน				
2 มื้อ	5	33.3%	6	40%
3 มื้อ	-	-	4	26.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
2.5. ดื่มน้ำ				
3 - 4 แก้ว	1	6.7%	4	26.7%
5 - 6 แก้ว	1	6.7%	5	33.3%
7 - 8 แก้ว	2	13.3%	1	6.7%
9 – 10 แก้ว	1	6.7%	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
2.6. ปัญหาการรับประทานอาหารก่อนการเจ็บป่วยครั้งนี้				
ไม่มี	5	33.3%	10	66.7%
มี ระบุ...	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากการศึกษาภาวะโภชนาการและเมตาบอลิซึมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน (ร้อยละ 100) แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) พบว่าเพศหญิงส่วนใหญ่มีน้ำหนัก 41–50 กิโลกรัม จำนวน 6 คน (ร้อยละ 40) และมีส่วนสูง 151–160 เซนติเมตร จำนวน 6 คน (ร้อยละ 40) ส่วนเพศชายส่วนใหญ่มีน้ำหนัก 61–70 กิโลกรัม จำนวน 2 คน และมีส่วนสูง 161–170 และ 171–180 เซนติเมตร อย่างละ 2 คน ด้านค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พบว่าเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 17.4–20.0 จำนวน 7 คน (ร้อยละ 46.7) ขณะที่เพศชายส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20.1–22.7 จำนวน 3 คน (ร้อยละ 20) ตามข้อมูลในตาราง ด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบว่าเพศชายทั้งหมดรับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 33.3) ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่รับประทานอาหารวันละ 2 มื้อ จำนวน 6 คน (ร้อยละ 40) และรับประทานวันละ 3 มื้อ จำนวน 4 คน (ร้อยละ 26.7) สำหรับการดื่มน้ำ

พบว่าเพศชายส่วนใหญ่ดื่มน้ำวันละ 7–8 แก้ว จำนวน 2 คน (ร้อยละ 13.3) ขณะที่เพศหญิงส่วนใหญ่ดื่มน้ำวันละ 5–6 แก้ว จำนวน 5คน (ร้อยละ 33.3) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่มีปัญหาการรับประทานอาหารก่อนการเจ็บป่วยครั้งนี้

3. การขับถ่าย				
3.1. การขับถ่ายปัสสาวะ				
- ปกติ	5	33.3%	10	66.7%
- ไม่ปกติ ระบุ...	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
3.2. การขับถ่ายอุจจาระ				
- ปกติ	5	33.3%	9	60%
- ไม่ปกติ ระบุ... (ขับถ่ายยาก)	-	-	1	6.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน พบว่าด้านการขับถ่ายปัสสาวะ กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีการขับถ่ายปัสสาวะเป็นปกติ จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100) โดยไม่พบผู้ที่มีความผิดปกติ ส่วนด้านการขับถ่ายอุจจาระ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการขับถ่ายอุจจาระเป็นปกติ 14 คน (ร้อยละ 93.3) แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 9 คน ขณะที่เพศหญิง 1 คน (ร้อยละ 6.7) มีอาการขับถ่ายยาก

4. กิจกรรมและการออกกำลังกาย				
4.1. ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน				
- ช่วยเหลือตัวเองได้ดี	5	33.3%	10	66.7%
- ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
4.2. การออกกำลังกาย				
- สม่ำเสมอ	2	13.3%	1	6.7%
- นานๆครั้ง	3	20%	8	53.3%
- ไม่เคย	-	-	1	6.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน พบว่าทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดี (ร้อยละ 100) สำหรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบว่าเพศชายส่วนใหญ่ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 20) และออกกำลังกายสม่ำเสมอ จำนวน 2 คน (ร้อยละ 13.3) ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง จำนวน 8 คน (ร้อยละ 53.3) รองลงมาคือออกกำลังกายสม่ำเสมอและไม่เคยออกกำลังกาย อย่างละ 1 คน (ร้อยละ 6.7) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ จึงควรส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี

5. การนอนหลับพักผ่อน				
5.1. อุปนิสัยในการนอนหลับ				
4 – 5 ชั่วโมง	2	13.3%		
6 - 7 ชั่วโมง	2	13.3%	7	46.7%
8 - 9 ชั่วโมง	-	-	3	20%
10 - 11 ชั่วโมง	-	-	-	-
12 ชั่วโมง	1	6.7%	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
เพียงพอ	2	13.3%	6	40%
ไม่เพียงพอ	3	20%	4	26.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
5.2. ปัญหาการนอนหลับ				
ไม่มี	3	20%	9	60%
มี ระบุ... (ไม่ง่วง/ การเรียน)	2	13.3%	1	6.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
5.3. การใช้ยานอนหลับ				
- ไม่เคย	5	33.3%	10	66.7%
- ใช้ประจำ	-	-	-	-
- ใช้เป็นบางครั้ง ระบุ...	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน พบว่าด้านอุปนิสัยในการนอนหลับ เพศชายส่วนใหญ่มีระยะเวลานอนวันละ 4–7 ชั่วโมง จำนวน 4 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่นอน 4-5 ชั่วโมง จำนวน 2 คน และผู้ที่นอน 6-7 ชั่วโมง จำนวน 2 คน ส่วนอีก 1 คนนอน 12 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่เพศหญิงส่วนใหญ่

นอนวันละ 6–7 ชั่วโมง จำนวน 7 คน (ร้อยละ 46.7) รองลงมาคือนอนวันละ 8–9 ชั่วโมง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 20) เมื่อประเมินความเพียงพอของการนอนหลับ พบว่าเพศชาย 3 คน (ร้อยละ 20) และเพศหญิง 4 คน (ร้อยละ 26.7) พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่วนผู้ที่พักผ่อนเพียงพอมีเพศชาย 2 คน (ร้อยละ 13.3) และเพศหญิง 6 คน (ร้อยละ 40) ด้านปัญหาการนอนหลับ พบว่าเพศชาย 3 คน (ร้อยละ 20) และเพศหญิง 9 คน (ร้อยละ 60) ไม่มีปัญหาการนอนหลับ ขณะที่เพศชาย 2 คน (ร้อยละ 13.3) และเพศหญิง 1 คน (ร้อยละ 6.7) มีปัญหาการนอนหลับ โดยระบุว่าเกิดจากการไม่ง่วงหรือการเรียน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน (ร้อยละ 100) ไม่เคยใช้ยานอนหลับ

6. การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์				
6.1. การเจ็บป่วยครั้งนี้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์				
- ภาพลักษณ์	1	6.7%	3	20%
- อารมณ์และจิตใจ	2	13.3%	6	40%
- ความสามารถในการปฏิบัติ	2	13.3%	1	6.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
6.2. สิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด				
ไม่มี	5	33.3%	9	60%
มี ระบุ... (สอบ)	-	-	1	6.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน (ร้อยละ 100) แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน พบว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างในด้านอารมณ์และจิตใจมากที่สุด จำนวน 8 คน รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์ จำนวน 4 คน และด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ตามข้อมูลในตาราง สำหรับสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีความเครียด จำนวน 14 คน (ร้อยละ 93.3) โดยเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 9 คน (ร้อยละ 60) ขณะที่เพศหญิง 1 คน (ร้อยละ 6.7) มีความเครียดจากการสอบ

7. เพศสัมพันธ์และการเจริญพันธุ์				
7.1. ประวัติการมีเพศสัมพันธ์				
- ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	2	13.3%	10	66.7%
- ไม่มีปัญหา	3	20%	-	-
- มีปัญหา ระบุ...	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%

7.2. ประวัติพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 ข้อ				
- คู่เพศสัมพันธ์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	-	-	-	-
- มีเพศสัมพันธ์กับชาย/หญิงให้บริการไม่ใช้ถุงยาง	-	-	-	-
- มีเพศสัมพันธ์มากกว่า 1 คน	-	-	-	-
- มีเพศสัมพันธ์กับคนใหม่	-	-	-	-
- ไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือแตกรั่วหลุด	3	20%	-	-
อื่นๆ ระบุ... (ไม่เคย)	2	13.3%	10	66.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
7.3. ประวัติการตรวจ HIV				
- ไม่เคย	4	26.7%	10	66.7%
- เคย (1 ครั้ง)	1	6.7%	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
7.4. ประวัติประจำเดือน				
- ยังไม่มีประจำเดือน	-	-	-	-
- หมดประจำเดือน	-	-	-	-
- ปกติ	-	-	10	100%
- ผิดปกติ ระบุ...	-	-	-	-
รวม	-	-	10	100%
หมายเหตุ: ประเมินประวัติประจำเดือนเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จำนวน 10 คน (ร้อยละ 100 ของเพศหญิงทั้งหมด) โดยพบว่าทุกคนมีประจำเดือนปกติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศชายไม่มีข้อมูลในหัวข้อนี้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินประวัติประจำเดือน				
7.5. เต้านม/ หัวนม (เฉพาะหญิงตั้งครรภ์)				
- ปกติ	-	-	-	-
- ไม่ปกติ ระบุ...	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
หมายเหตุ: ไม่มีหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มตัวอย่าง จึงไม่มีข้อมูลการประเมิน				

สรุปผล: จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน (ร้อยละ 100) แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน พบว่าด้านประวัติการมีเพศสัมพันธ์ เพศชาย 2 คน (ร้อยละ 13.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) ระบุว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนเพศชาย 3 คน (ร้อยละ 20) ระบุว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์
ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ พบว่าเพศชาย 3 คน (ร้อยละ 20) ระบุว่าไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือถุงยางอนามัยแตก รั่ว หรือหลุด ขณะที่เพศชาย 2 คน (ร้อยละ 13.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) ระบุว่าไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงตามรายการที่กำหนด สำหรับประวัติการตรวจ HIV พบว่าเพศชาย 4 คน (ร้อยละ 26.7) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) ไม่เคยตรวจ HIV ขณะที่เพศชาย 1 คน (ร้อยละ 6.7) เคยตรวจ HIV จำนวน 1 ครั้ง ด้านประวัติประจำเดือน: จากการประเมินกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 10 คน พบว่าทั้งหมดมีประจำเดือนปกติ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงทั้งหมด โดยไม่มีข้อมูลประวัติประจำเดือนของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย เนื่องจากหัวข้อนี้เป็นการประเมินเฉพาะเพศหญิง ด้านเต้านม/ หัวนม (เฉพาะหญิงตั้งครรภ์) ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ จึงไม่มีข้อมูลการประเมินเต้านมและหัวนม และไม่สามารถสรุปผลการตรวจในหัวข้อนี้ได้

8. บทบาทและสัมพันธภาพ				
8.1. บทบาทในครอบครัว				
- ลูก	5	33.3%	10	66.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
8.2. สัมพันธภาพในครอบครัว				
- ดี	5	33.3%	10	66.7%
- ไม่ดี	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
8.3. อาชีพ				
- นักศึกษา	5	33.3%	10	66.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
8.4. รายได้				
- ไม่มีรายได้	3	20%	8	53.3%
- มีรายได้	2	13.3%	2	13.3%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
8.5. การศึกษา				
- ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี	5	33.3%	10	66.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%

8.6. ผู้ดูแลที่บ้าน				
- บิดา - มารดา	3	20%	6	40%
- ไม่มี	2	13.3%	4	26.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
8.7. การเจ็บป่วย				
- ไม่มี	5	33.3%	10	66.7%
- มี ระบุ...	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) พบว่าผู้ป่วยทุกคนมีบทบาทในครอบครัวเป็นบุตร และมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100) ด้านอาชีพพบว่าทุกคนเป็นนักศึกษา จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100) ด้านรายได้ พบว่าเพศชายไม่มีรายได้ 3 คน (ร้อยละ 20) และมีรายได้ 2 คน (ร้อยละ 13.3) ส่วนเพศหญิงไม่มีรายได้ 8 คน (ร้อยละ 53.3) และมีรายได้ 2 คน (ร้อยละ 13.3) ด้านการศึกษา ทุกคนกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100) ด้านผู้ดูแลที่บ้าน พบว่าเพศชายมีบิดา–มารดาเป็นผู้ดูแล 3 คน (ร้อยละ 20) และไม่มีผู้ดูแล 2 คน (ร้อยละ 13.3) ส่วนเพศหญิงมีบิดา–มารดาเป็นผู้ดูแล 6 คน (ร้อยละ 40) และไม่มีผู้ดูแล 4 คน (ร้อยละ 26.7) นอกจากนี้ ผู้ป่วยทุกคนไม่มีการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ระบุไว้ จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100)

9. สติปัญญา การรับรู้และประสาทสัมผัส				
9.1. การรับรู้ก่อนการเจ็บป่วย				
• รับรู้บุคคล เวลา สถานที่				
- ปกติ	5	33.3%	10	66.7%
- ไม่ปกติ	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
• ความจำและการโต้ตอบ				
- ปกติ	5	33.3%	10	66.7%
- ไม่ปกติ	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
9.2. การรับรู้แรกรับ				
• รับรู้บุคคล เวลา สถานที				

- ปกติ	5	33.3%	10	66.7%
- ไม่ปกติ	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
● ความจำและการโต้ตอบ				
- ปกติ	5	33.3%	10	66.7%
- ไม่ปกติ	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
9.3. ความเจ็บป่วย				
- ไม่มี	3	20%	8	53.3%
- มี	2	13.3%	2	13.3%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
9.4. ลักษณะการปวด				
- เป็นบางครั้ง	2	13.3%	2	13.3%
- ตลอดเวลา	-	-	-	-
- อื่นๆ... (ไม่มีอาการปวด)	3	20%	8	53.3%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
หมายเหตุ: เพศชายมีอาการปวดเอวจำนวน 1 คน และปวดหลัง บ่า ไหล่จำนวน 1 คน เพศหญิงมีอาการปวดหัวจำนวน 1 คน และปวดขมับจำนวน 1 คน				

สรุปผล: จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) พบว่า ก่อนการเจ็บป่วย ผู้ป่วยทุกคนมีการรับรู้บุคคล เวลา และสถานที่ รวมถึงความจำและการโต้ตอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100) และการรับรู้แรกรับ ผู้ป่วยทุกคนยังมีการรับรู้และความจำอยู่ในเกณฑ์ปกติ จำนวน 15 คน (ร้อยละ 100) ด้านความเจ็บป่วย พบว่าเพศชายไม่มีอาการเจ็บป่วย 3 คน (ร้อยละ 20) และมีอาการเจ็บป่วย 2 คน (ร้อยละ 13.3) ส่วนเพศหญิงไม่มีอาการเจ็บป่วย 8 คน (ร้อยละ 53.3) และมีอาการเจ็บป่วย 2 คน (ร้อยละ 13.3) สำหรับลักษณะอาการปวด พบว่าเพศชายมีอาการปวดเป็นบางครั้ง 2 คน (ร้อยละ 13.3) และไม่มีอาการปวด 3 คน (ร้อยละ 20) ส่วนเพศหญิงมีอาการปวดเป็นบางครั้ง 2 คน (ร้อยละ 13.3) และไม่มีอาการปวด 8 คน (ร้อยละ 53.3) โดยไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการปวดตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้และความจำปกติ และส่วนใหญ่ไม่มีอาการปวด

10. ความเครียดและความทนต่อความเครียด				
10.1. การตัดสินใจในเรื่องสำคัญ				
- ตัดสินใจเอง	5	33.3%	9	60%
- ให้ผู้อื่นตัดสินใจให้	-	-	1	6.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%
10.2. วิธีแก้ความเครียดเมื่อไม่สบายใจ				
- ปรึกษาผู้ไว้ใจ	4	26.7%	4	26.7%
- ทำงานอดิเรก	1	6.7%	5	33.3%
- แยกตัว	-	-	1	6.7%
- ใช้ยา	-	-	-	-
- อื่นๆ ระบุ...	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) พบว่า ด้านการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เพศชายทั้ง 5 คน (ร้อยละ 33.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ส่วนเพศหญิง 9 คน (ร้อยละ 60) ตัดสินใจด้วยตนเอง และ 1 คน (ร้อยละ 6.7) ให้ผู้อื่นช่วยตัดสินใจ สำหรับวิธีแก้ความเครียดเมื่อไม่สบายใจ พบว่าเพศชายส่วนใหญ่ปรึกษาผู้ใกล้ชิด 4 คน (ร้อยละ 26.7) และทำงานอดิเรก 1 คน (ร้อยละ 6.7) ส่วนเพศหญิงปรึกษาผู้ใกล้ชิด 4 คน (ร้อยละ 26.7) ทำงานอดิเรก 5 คน (ร้อยละ 33.3) และแยกตัว 1 คน (ร้อยละ 6.7) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกปรึกษาผู้ใกล้ชิดหรือทำงานอดิเรกเพื่อจัดการกับความเครียด

11. ความเชื่อและค่านิยม				
11.1. การเจ็บป่วยครั้งนี้เชื่อว่ามีสาเหตุจาก				
- ดูแลตนเองไม่ถูกต้อง	5	33.3%	9	60%
- ตามวัย	-	-	1	6.7%
- เคราะห์กรรม	-	-	-	-
- อื่นๆ...	-	-	-	-
รวม	5	33.3%	10	66.7%
11.2. สิ่งยึดเหนี่ยวในขณะเจ็บป่วย				

- ครอบครัว	5	33.3%	4	26.7%
- ศาสนา	-	-	5	33.3%
- อื่นๆ ระบุ... (ผู้ไว้ใจ)	-	-	1	6.7%
รวม	5	33.3%	10	66.7%

สรุปผล: จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน (ร้อยละ 33.3) และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 66.7) พบว่า ด้านความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วย เพศชายทั้ง 5 คน (ร้อยละ 33.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) เชื่อว่าเกิดจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้อง ส่วนเพศหญิง 9 คน (ร้อยละ 60) เชื่อว่าเกิดจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้อง และ 1 คน (ร้อยละ 6.7) เชื่อว่าเกิดจากตามวัย ด้านสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในขณะเจ็บป่วย พบว่าเพศชายทั้ง 5 คน (ร้อยละ 33.3) ยึดเหนี่ยวจิตใจจากครอบครัว ส่วนเพศหญิง 4 คน (ร้อยละ 26.7) ยึดเหนี่ยวจิตใจจากครอบครัว 5 คน (ร้อยละ 33.3) ยึดเหนี่ยวจิตใจจากศาสนา และ 1 คน (ร้อยละ 6.7) ระบุสิ่งอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและครอบครัว

ผลการประเมินภาวะสุขภาพและแบบแผนสุขภาพของผู้ป่วย

จากการประเมินกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน เป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีรายละเอียดตามแบบแผนสุขภาพ 11 ด้าน ดังนี้

1) การรับรู้และการดูแลสุขภาพ: ผู้ป่วยทุกคนมีสุขภาพก่อนเจ็บป่วยอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่เลือกซื้อยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย และส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วย
2) ภาวะโภชนาการและเมตาบอลิซึม: ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและดื่มน้ำแตกต่างกัน โดยไม่พบปัญหาด้านการรับประทานอาหารตามข้อมูลที่ประเมิน
3) การขับถ่าย: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระได้ตามปกติ มีเพศหญิง 1 คนที่มีปัญหาถ่ายอุจจาระลำบาก
4) กิจกรรมและการออกกำลังกาย: ผู้ป่วยทุกคนสามารถดูแลตนเองในชีวิตประจำวันได้ดี ส่วนใหญ่มีการออกกำลังกายเป็นบางครั้ง
5) การนอนหลับพักผ่อน: ผู้ป่วยมีระยะเวลาการนอนหลับแตกต่างกัน และมีบางส่วนที่พักผ่อนไม่เพียงพอ โดยไม่มีผู้ใช้ยาช่วยนอนหลับ
6) การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีความเครียดจากการเจ็บป่วย มีเพศหญิง 1 คนที่มีความเครียดเกี่ยวกับการสอบ
7) เพศสัมพันธ์และการเจริญพันธุ์: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาตามข้อมูลที่ประเมิน ผู้ป่วยหญิงทั้งหมด 10 คนมีประจำเดือนปกติ
8) บทบาทและสัมพันธภาพ: ผู้ป่วยทุกคนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี และส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานะนักศึกษา โดยมีครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลัก
9) สติปัญญา การรับรู้และประสาทสัมผัส: ผู้ป่วยทุกคนมีการรับรู้บุคคล เวลา สถานที่ ความจำ และการโต้ตอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีผู้ป่วยบางส่วนที่มีอาการปวดเป็นบางครั้ง
10) ความเครียดและความทนต่อความเครียด: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยตนเอง และจัดการความเครียดโดยปรึกษาผู้ที่ไว้วางใจหรือทำงานอดิเรก
11) ความเชื่อและค่านิยม: ผู้ป่วยส่วนใหญ่เชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการดูแลตนเองไม่ถูกต้อง โดยมีครอบครัวและศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

สรุปผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินแบบแผนสุขภาพทั้ง 11 ด้านของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 10 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถดูแลตนเองและทำกิจวัตรประจำวันได้ดี มีการขับถ่ายปัสสาวะตามปกติ และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการขับถ่ายอุจจาระ นอกจากนี้ ผู้ป่วยทุกคนมีการรับรู้บุคคล เวลา และสถานที่ รวมถึงความจำและการโต้ตอบอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อแรกรับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการดูแลตนเองและการรับรู้ที่เหมาะสม

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เลือกซื้อยารับประทานเองเมื่อเจ็บป่วย และมีการออกกำลังกายเป็นบางครั้ง ขณะที่พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ และการนอนหลับพักผ่อนมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยมีผู้ป่วยบางส่วนที่พักผ่อนไม่เพียงพอ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การดื่มน้ำให้เพียงพอ การพักผ่อน และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ยาอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

ด้านจิตใจและสังคม พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี และสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดการความเครียดด้วยการปรึกษาบุคคลที่ไว้วางใจหรือทำงานอดิเรก อย่างไรก็ตาม ยังพบผู้ป่วยบางรายที่มีความเครียดเกี่ยวกับการสอบ และผู้ป่วยบางส่วนที่มีอาการปวดเป็นบางครั้ง ซึ่งควรได้รับการดูแลและให้คำแนะนำตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ครอบครัว ศาสนา และบุคคลที่ไว้วางใจยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของผู้ป่วย